

La cystographie est un examen radiologique rapide de la vessie. La vessie est doucement remplie d'un produit de contraste par une sonde, ce qui la rend bien visible sur les clichés. Cela permet à votre chirurgien de vérifier qu'une réparation est bien cicatrisée et étanche, ou de détecter une fuite, une connexion anormale ou un reflux vers les reins.

À propos de cet examen

La vessie n'est normalement pas bien visible sur une radiographie standard. La cystographie la remplit avec un **produit de contraste** qui apparaît en blanc, permettant d'évaluer sa forme et son fonctionnement. Votre chirurgien peut prescrire une cystographie pour :

- Confirmer qu'une **réparation chirurgicale a cicatrisé** et ne fuit pas — souvent avant le retrait d'une sonde
- Rechercher une **fuite** après un traumatisme ou une chirurgie
- Détecter une connexion anormale (une **fistule**) entre la vessie et un autre organe
- Vérifier la présence d'un reflux de l'urine vers les reins (**reflux vésico-urétéral**)

L'introduction du produit de contraste dépend de votre situation :

- Si vous n'avez **aucune sonde**, une petite sonde est posée uniquement pour l'examen.
- Si vous avez déjà une **sonde urétrale** ou un **cathéter sus-pubien**, le produit passe généralement par celle-ci — aucune nouvelle sonde n'est nécessaire.

Est-ce sans danger ?

Oui. La cystographie est un examen courant et à faible risque. La dose de rayonnement est faible, et le produit de contraste à base d'eau est éliminé dans l'urine. La plupart des patients ne ressentent qu'une sensation de plénitude ou une légère pression. Les effets indésirables rares — infection urinaire, légère brûlure ou crampes — sont habituellement bénins et disparaissent rapidement.

COMPRENDRE LES TERMES

Cystographie

Radiographie de la vessie réalisée pendant qu'elle est remplie de produit de contraste.

Vessie

Poche musculaire qui stocke l'urine jusqu'à la miction.

Produit de contraste

Liquide qui apparaît en blanc sur la radiographie pour rendre la vessie visible.

Sonde

Tube fin et souple utilisé pour remplir la vessie de produit de contraste.

Cathéter sus-pubien

Sonde qui draine la vessie par le bas-ventre ; le produit de contraste peut y passer.

Fistule

Connexion anormale entre la vessie et un autre organe, détectable par cystographie.

Reflux

Remontée de l'urine de la vessie vers les reins.

Clichés mictionnels

Radiographies supplémentaires prises pendant la miction, si nécessaire.

EST-CE QUE ÇA FAIT MAL ? La plupart des patients ne ressentent qu'une sensation de plénitude ou une légère pression au remplissage de la vessie, sans douleur vive. Si une sonde est posée pour l'examen, vous pouvez ressentir une brève brûlure. L'équipe peut ralentir ou s'arrêter à tout moment — dites-le leur. L'examen dure généralement 15–30 minutes.

Comment vous préparer (avant l'examen)

La préparation est très simple. Dans la plupart des cas :

- Vous pouvez **manger et boire normalement** et prendre vos **médicaments habituels**, sauf indication contraire.
- Si vous avez une sonde urétrale ou un cathéter sus-pubien, **laissez-le en place** — le produit de contraste y passe souvent.
- Vous pouvez généralement **rentrez seul chez vous**, car aucune sédation n'est nécessaire.

Informez votre équipe à l'avance si vous :

- Avez déjà eu une réaction à un produit de contraste radiologique ou à l'iode
- Prenez un anticoagulant
- Présentez des signes d'infection urinaire (brûlures, fièvre, urine trouble ou malodorante) — une infection active peut entraîner le report de l'examen

Déroulement de l'examen

- 1 Vous vous allongez sur la table de radiologie. Si vous n'avez pas encore de sonde, une petite sonde est délicatement posée ; si vous en avez déjà une, elle est connectée.
- 2 Le produit de contraste est introduit lentement dans la vessie pendant que des clichés sont pris. Il vous sera demandé de rester immobile et de respirer normalement.
- 3 Il peut vous être demandé d'**uriner** pour que l'équipe prenne des clichés de la vidange vésicale (lorsque cela fait partie de l'examen).
- 4 Les clichés sont analysés et la sonde est retirée — ou votre sonde existante est laissée en place.

Après l'examen

- Vous pouvez généralement rentrer chez vous et reprendre vos **activités normales immédiatement**.
- Vous pouvez ressentir de **légères brûlures à la miction** pendant un jour environ. Boire davantage d'eau aide à les soulager.
- Vous pouvez observer une **légère teinte rosée** dans l'urine pendant peu de temps. C'est fréquent et disparaît généralement en un jour.

Appelez votre équipe soignante si vous avez :

- De la fièvre ou des frissons
- Des difficultés à uriner, ou une impossibilité totale d'uriner
- Des saignements abondants ou des caillots dans les urines
- Des douleurs ou des crampes abdominales qui s'aggravent

TROIS CHOSES À RETENIR

1. La cystographie est une radiographie rapide et sans danger : elle remplit la vessie de produit de contraste pour vérifier qu'une réparation a cicatrisé ou détecter une fuite, une fistule ou un reflux.
2. La préparation est minimale. Laissez toute sonde ou cathéter en place, et signalez toute allergie au contraste, tout anticoagulant ou signe d'infection urinaire.
3. La plupart des patients ne ressentent qu'une plénitude et rentrent chez eux aussitôt. De légères brûlures ou une teinte rosée des urines pendant un jour sont normales — buvez bien.